

УДК: 618.19-006.6-07(574.1)

Т.Т.Аманов

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер

## Возможности и перспективы диагностики рака молочной железы в Западно-Казахстанской области

*Аннотация. В статье показано использование комплекса для стереотаксической биопсии - MammoTest, который позволяет получить верификацию опухолевого процесса не только образований до 0,5 см, но и образований, локализованных близко к большой грудной мышце и аксиллярных областях. Диагностику обычным методом пункционной биопсии провести крайне сложно с учетом малых размеров опухоли. Метод доступен широкой возрастной группе и менее травматичен, а в экономическом плане обоюдно выгоден как для медицинской организации, так и для больного в целом.*

*Ключевые слова: рак молочной железы, комплекс для стереотаксической биопсии.*

Ежегодно в мире регистрируется около 10 млн. новых случаев онкологических заболеваний, и более 6,2 млн. человек умирают от рака. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире выявляется около 1 млн. новых случаев рака молочной железы (РМЖ).

Рак молочной железы — злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы.

### Эпидемиология

В мире это наиболее частая форма рака среди женщин. Заболеванию подвержены женщины в возрасте от 13 до 90 лет. Это также второе по частоте после рака лёгких онкологическое заболевание в общей популяции (считая и мужское население).

РМЖ относится к агрессивной злокачественной опухоли, склонной к быстрой диссеминации преимущественно лимфогенным путем. Тревогу вызывает тот факт, что происходит рост числа заболеваний женщин фертильного возраста. В последние годы РМЖ занимает первое место в структуре онкологической патологии у всех женщин во всех индустриальных странах, включая Казахстан.

В Западно-Казахстанской области удельный вес женщин, больных РМЖ, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями составляет 10,5%, а удельный вес смертности от РМЖ составляет 6,8%, что представляет собой актуальную проблему региона. В области за 10 лет наблюдается рост заболеваемости РМЖ с 15,5 на 100 тыс. населения в 2002 году до 29,9 на 100 тыс. населения в 2012 г.

Проявления рака молочной железы могут быть настолько разными, насколько и сами женщины, страдающие им. Высокая заболеваемость определяет стратегию борьбы, которая ориентирована на сокращение

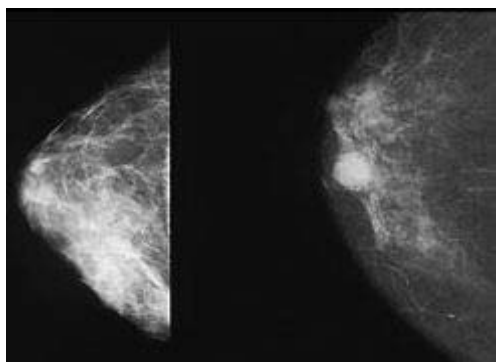
смертности, увеличение безрецидивного периода и улучшение качества жизни.

### Диагностика

Возникновение рака в органе, удобном для осмотра и пальпации, могло бы быть вполне доступным для своевременного распознавания. Однако, как свидетельствует опыт клинической онкологии, процент запущенных случаев к моменту постановки диагноза достигает 30-40%. Это обусловлено многообразием проявлений клинических, рентгенологических, сонографических и патоморфологических форм злокачественных новообразований МЖ, что затрудняет правильность постановки диагноза и что в определенной степени может объяснять неудачные результаты лечения. Сегодня невозможно акцентировать внимание на диагностике доклинических форм РМЖ без применения современных лучевых методов исследования. Современная лучевая диагностика заболеваний молочной железы включает целый ряд методов визуализации, основным из которых является рентгеновская маммография (ММГ) — «золотой стандарт», старейший и надежный метод, благодаря которому выявляется большинство злокачественных новообразований молочной железы. Чувствительность доходит до 95%, а специфичность — до 90%. ММГ не информативна в молодом возрасте в связи с повышенной плотностью ткани молочной железы. Ультразвуковое исследование молочной железы — безопасный метод диагностики у женщин молодого возраста, позволяющий использовать его многократно, даже у беременных и кормящих молодых женщин. Позволяет оценить состояние молочных желез у молодых женщин с плотными молочными железами, диагностировать рентгенонегативные новообразования, образования расположенные вблизи грудной стенки, что невозможно при маммографии, а также выполнять пункционные биопсии непальпируемых образований под визуальным контролем.

Доказана ценность МРТ при многих заболеваниях, включая обнаружение и определение стадии рака молочной железы. С помощью МРТ можно обследовать плотные образования молочных желез у молодых женщин, а также импланты молочных желез, что трудно сделать с помощью обычной маммографии, возможна дифференциальная диагностика между соединительной тканью послеоперационных шрамов и рецидивирующими опухолями молочной железы, оценка множественных опухолей перед нерадикальными операциями с сохранением груди.

Позитронно-эмиссионная томография может



определить первичную локализацию рака груди, локорегионарные и отдаленные метастазы. При оценке отдаленных метастазов рака молочной железы, ПЭТ превосходит анатомические методы визуализации и очень чувствительна при локализации очагов рака груди в мягких тканях. Отрицательным моментом является дороговизна этого метода диагностики.

Остеосцинтиграфия позволяет определять участки накопления радиофармпрепарата в костях с дальнейшей верификацией данных участков на наличие в них метастазов.

Сегодня в рамках улучшения выявления ранних форм РМЖ проводится регулярно исследование целевой группы женщин, что уже приносит позитивные результаты. Однако в ходе проводимой работы проблематичным моментом становится диагностика непальпируемых образований, т.е. наличие опухоли на рентгенологическом снимке, но отсутствие его при объективном осмотре. Ранее единственным способом диагностики было назначение оперативного вмешательства. Однако и у данного метода без учета его положительных моментов есть ряд отрицательных, которые стоит перечислить. Во-первых, это оперативный и анестезиологический риск; во-вторых, трудность в определении локализации патологического участка при проведении операции; в-третьих, травматичность метода и наконец, эмоциональное напряжение, которое испытывает обследуемая женщина. И сегодня в целях повышения эффективности ранней диагностики заболеваний молочных желез, использование аппаратов для проведения стереотаксической биопсии является как экономически целесообразным, так и удобным для населения.

## Материал и методы

На базе областного онкологического диспансера введена в полную эксплуатацию система комплекса для стереотаксической биопсии - MammoTest. Особенностью данного оборудования является свободный доступ в 360° к месту пункции по кратчайшему расстоянию, а также цифровая система визуализации, обеспечивающая прекрасные контрастные изображения с высоким пространственным разрешением. Все вышеперечисленное дает возможность проводить биопсию образований, расположенных близко к большой грудной мышце или в аксиллярных областях.

Исследованию подлежали женщины с непальпируемыми образованиями размерами до 0,5 см и с образованиями, расположенными в труднодоступных локализациях, а именно, в непосредственной близости к большой грудной мышце и аксиллярным областям, что зачастую требует в тактическом плане проведение

оперативного лечения. Возрастной предел подлежащих обследованию колебался от 34-х до 77-ми лет.

## Результаты и обсуждение

За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. проведено всего 57 исследований на данном аппарате. Средняя длительность одного обследования составляет 40-50 минут. По результатам диагностики, с учетом рентгенологической структуры с подозрением на рак, получены следующие данные. Выявлено 14 случаев рака, все гистологически верифицированные. В разрезе возрастов среди женщин, подвергшихся обследованию, выявлены в возрастном коридоре с 72 до 77 лет - 2 случая, с 62 до 71 года - 2 случая, с 52 до 60 лет - 5 случаев, с 42 лет до 51 года - 4 и 1 случай в возрастной группе 32-41 лет. Кроме того выявлены 2 случая с доброкачественными образованиями - фиброаденомы, жировые изменения (липома) - 4 случая, фиброзно-кистозные изменения 17 случаев, образования воспалительного генеза 2 случая. Также важным моментом следует отметить, что 15 случаев при



рентгенологическом подозрении на рак, гистологическая структура соответствовала норме. И лишь в 3-х случаях гистологический материал был неинформативен.

## Выводы

Таким образом, использование стереотаксической приставки является удобным методом диагностики, как для пациента, так и для врача. Использование стереотаксического метода позволяет получить верификацию опухолевого процесса не только образований до 0,5 см, но и образований, локализованных близко к большой грудной мышце и аксиллярных областях. Диагностику обычным методом пункционной биопсии провести крайне сложно с учетом малых размеров опухоли. Метод доступен широкой возрастной группе и менее травматичен, а в экономическом плане обоюдно выгоден как для медицинской организации, так и для больного в целом.

## Список литературы

1. Хасанов Р.Ш. Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы // Ремеდიум Приволжье. - 2009. - № 6.
2. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. Скрининг рака молочной железы // Практическая онкология. - 2010. - Т. 11, №2. - С. 60-65
4. Мат. V Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные вопросы клинической и экспериментальной онкологии». - М.: НИИ-Природа, 2005. - С. 101, 252 с.
5. Особенности морфологической верификации в диагностике рака молочной железы // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2008. - Т. 4, №2

Тужырым

Т.Т.Аманов

Батыс Қазақстан облыстық онкологиялық диспансері

Батыс Қазақстан облысындағы сүт безі қатерлі ісігін анықтаудың мүмкіндіктері мен келешегі

Мақалада 0,5 см дейінгі түзілістерді ғана емес, Үлкен кеуде булыңы етте және аксиллярлы аймаққа жақын орналасқан ісіктік үрдістердің верификациясын алуға мүмкіндік беретін, стереотаксикалық биопсияға арналған кешен — MammoTest — ті қолдану көрсетілген. Шкімді өлшемдері кішкене болғандықтан қарапайым пункционды биопсия әдісімен анықтау өте қиын. Бертген әдію әр түрлі жастағы топтарда қолдануға тиімді және жарақат алу мүмкіндігі төмен, ал экономикалық жағынан медициналық мекемеге де науқасқа да тиімді.

Түйінді сөздер: сүт безі, стереотаксикалық биопсияға арналған кешен.

Summary

Possibilities and perspectives of breast cancer diagnostics in West Kazakhstan.

West Kazakhstan Regional Oncology Center

The article shows how to use the complex for stereotactic biopsy-Mammotest — that allows to get histological verification of tumor process in small size of tumors (0.5 cm), tumors with close localization to muscles, and axillary. This procedure is available for extensive age category and low traumatic, beneficial to medical organization and for patient also.

Key words: breast cancer, complex for stereotaxis biopsy.